

Uretroplastia (reparación de la uretra)

WARWIKI

Información para el paciente · Cirugía para reparar un estrechamiento de la uretra

La uretroplastia es una cirugía para reparar una sección estrecha y con cicatriz de la uretra — el conducto que lleva la orina fuera de su cuerpo. El estrechamiento (una estrechez) hace más lento o bloquea su chorro de orina; la uretroplastia lo vuelve a abrir y es la reparación más duradera y de mayor permanencia. Esta hoja explica cómo funciona, cómo prepararse y qué esperar.

Acerca de este procedimiento

Una **estrechez** es un punto cicatrizado y estrecho de la uretra que dificulta vaciar la vejiga. A diferencia de solo estirar o cortar el estrechamiento (que a menudo vuelve a aparecer), la uretroplastia **reconstruye** la uretra hasta un ancho normal — la solución más confiable y duradera, con un éxito de alrededor del **85–95%**. La forma de hacerla depende de dónde está el estrechamiento y de cuán largo es:

- La **incisión** puede estar en el **pene**, en la zona entre el escroto y el ano (el **perineo**), o en ambos — donde se encuentre el estrechamiento.
- Un estrechamiento **corto** se puede **quitar y unir con puntos los extremos sanos**.
- Un estrechamiento **más largo** se **ensancha con un injerto** — por lo general un parche del interior de la mejilla (esta parte tiene su propia hoja).

Su cirujano le dirá cuál enfoque es adecuado para su estrechez.

¿Es segura?

La uretroplastia es una operación bien establecida y muy eficaz; la mayoría de los hombres tienen después una uretra abierta y duradera. Como toda cirugía, conlleva algún riesgo — sangrado, infección o que el estrechamiento vuelva con el tiempo (por lo general se puede volver a tratar). Los efectos sobre las erecciones o la eyaculación son poco frecuentes y suelen ser temporales.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Uretra

El conducto que lleva la orina fuera del cuerpo.

Estrechez

Un punto cicatrizado y estrecho de la uretra que hace más lento o bloquea el chorro de orina.

Uretroplastia

Cirugía para reparar el estrechamiento y reconstruir la uretra hasta un ancho normal.

Injerto

Un pequeño parche de su propio tejido (a menudo del interior de la mejilla) que se usa para ensanchar la uretra.

Perineo

La zona entre el escroto y el ano, donde se hace una de las incisiones comunes.

Sonda

Un tubo blando que se deja en la uretra durante unas 1–4 semanas mientras la reparación cicatriza.

Uretrograma

Una radiografía de la uretra, que se usa para comprobar que la reparación ha cicatrizado antes de retirar la sonda.

Anestesia general

Medicamento que lo mantiene dormido y sin dolor durante la cirugía.

¿LE DOLERÁ? La cirugía se hace con anestesia general o espinal, así que no siente nada durante ella. Después, espere dolor, hinchazón y moretones alrededor de la incisión (el pene o el perineo) durante un par de semanas — el hielo, un soporte escrotal y los medicamentos para el dolor ayudan. Cuando despierte, tendrá colocada una sonda. La duración de la cirugía depende de la reparación, a menudo de 2–4 horas.

Cómo prepararse (antes de la cirugía)

- Se hace con **anestesia general o espinal** — siga todas las instrucciones de la cirugía (ayuno y qué medicamentos suspender, incluidos los anticoagulantes).
- Un **análisis de orina** verifica si hay infección — una infección debe tratarse primero.
- **No fume** — retrasa la cicatrización. Si se podría usar un injerto de la mejilla, cuide su boca y es posible que le recomienden una limpieza dental.
- Prepárese para una **sonda después (unas 1–4 semanas)** y organice quién lo lleve a casa.

Avisé a su equipo con anticipación si usted:

- Toma un **anticoagulante**, o tiene una infección actual de la orina o de la piel
- Ha tenido una cirugía previa de la uretra, radiación o una afección de la piel como liquen escleroso

Qué sucede durante la cirugía

- 1 Está dormido o adormecido de la cintura para abajo con anestesia; se administran antibióticos.
- 2 El cirujano hace una incisión sobre el estrechamiento (pene, perineo o ambos) y abre el segmento cicatrizado.
- 3 Se repara el estrechamiento — se quita y se unen los extremos con puntos, o se ensancha con un injerto.
- 4 Se coloca una **sonda** para drenar la orina y proteger la reparación mientras cicatriza; se cierran las incisiones.

Después de la cirugía

- Se va a casa con una **sonda**, por lo general **1–4 semanas**. Su equipo le mostrará cómo cuidarla — no tire de ella.
- Hinchazón, moretones y algo de **orina con sangre** alrededor de la sonda son normales al principio.
- **Evite levantar peso, esfuerzos, bicicleta y relaciones** varias semanas (a menudo 6) para que cicatrice.
- Antes de retirar la sonda suele hacerse una **radiografía de la uretra** para confirmar que cicatrizó.

Llame a su equipo si tiene:

- La sonda **se sale, se obstruye o deja de drenar**
- Fiebre o escalofríos, o aumento del enrojecimiento, dolor o secreción en una incisión
- Sangrado abundante, o **no puede orinar** después de que le retiran la sonda

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La uretroplastia reconstruye una uretra estrecha y es la reparación más duradera. La incisión puede ir en el pene o el perineo, a veces con un injerto (de la mejilla) — su cirujano le explicará su reparación.
2. Para prepararse: siga el ayuno y los medicamentos indicados, trate primero cualquier infección, no fume y prepárese para una sonda después (1–4 semanas).
3. Mantenga la sonda hasta que su equipo la retire (tras una radiografía de cicatrización) y evite peso, esfuerzos y relaciones por varias semanas. Llame si la sonda deja de drenar, hay fiebre o no puede orinar tras retirarla.